

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062130-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LEONARDA DA SILVA

RECORRIDO: PAULO CESAR CABRAL GUIMARAES

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. DIAGNÓSTICO DE PÊNFIGO VULGAR. MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO CEAF PARA DOENÇA DIVERSA À DA AUTORA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA 793 DO STF. CUMPRIMENTO DIRECIONADO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ESTOQUE DO MEDICAMENTO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso determinando que o cumprimento da tutela deferida na origem seja, inicialmente, direcionado ao Estado do Rio de Janeiro, nos termos do tema 793 do STF, ante a possibilidade de estoque. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5062130-29.2024.4.02.5101

510014276725 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062130-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LEONARDA DA SILVA

RECORRIDO: PAULO CESAR CABRAL GUIMARAES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela União em face da decisão do Juízo de origem, que deferiu a tutela nos seguintes termos: (evento 25, DESPADEC1)

"LEONARDA DA SILVA, representada por Paulo Cesar Cabral Guimarães ajuíza a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, em face da União Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, objetivando que os Réus sejam condenados a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE, conforme prescrição médica, nos termos da inicial.

Analisando o acervo documental, depreende-se que a parte autora é portadora de diagnóstico principal de Pênfigo vulgar (CID: L10.0), necessitando da referida medicação, consoante laudo médico emitido pela Dra. Érika Monteiro França (CRM/RJ: 52124995-9), integrante dos quadros do Hospital Universitário o Clementino Fraga Filho (Evento 1- Anexo 2 Fls. 10/16).

O Parecer do NAT de Evento 22 informa que o medicamento ora pleiteado apresenta indicação em bula para o tratamento da patologia que acomete a parte autora.

De início, convém registrar que conquanto tenha a parte autora proposto dita ação em face da União Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro, restam legítimos todos a integrarem a demanda, eis que lhes compete garantir a sua saúde, conforme definição constitucional, ressaltando-se a compensação entre os entes, na medida de suas atribuições administrativas.

O art. 198 da Constituição Federal introduziu o Sistema Único de Saúde - S.U.S., que estabelece competência concorrente às três esferas do Poder Executivo para dispor sobre as ações e os serviços públicos de saúde em geral, "sic":

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.”

Regulamentando essa disposição normativa constitucional, a União editou a Lei nº. 8.080, de 19 setembro de 1990, que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”. Os arts. 6º e 7º da referida lei dispõem:

“ Art. 6º - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS:

I - a execução de ações:

.....

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.”

“Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

.....

I - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.”

Desse modo, não me parece que a Constituição ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à rede pública de saúde ou às ações de saúde. A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento, independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das atribuições administrativas de cada ente político.

Note-se que a Constituição Federal de 1988 conferiu status constitucional ao direito a saúde, relacionando-o diretamente com a Seguridade Social.

“Artigo 194 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.

“Artigo 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, o artigo 198 estatui que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, o qual tem como diretriz o atendimento integral.

Trata-se, portanto, de um direito que exige prestações de Estado. Como a parte autora logrou êxito em comprovar, por meio da documentação adunada aos autos, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC/2015 - prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações aliada ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação -, não lhe pode ser negada a concessão dos medicamentos necessários ao tratamento de sua enfermidade e a manutenção da própria vida.

O direito à saúde, além de se qualificar como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Estando incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica ex vi do artigo 6º, inciso I da Lei nº. 8.080/80, e sendo este composto pelos três entes, está evidenciada a obrigação dos réus a fornecerem os remédios receitados ao postulante.

Pela peculiaridade do caso concreto e devido à sua urgência, há que se deferir a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, dada a saúde debilitada da requerente e a gravidade da doença.

*Cabendo aos componentes do SUS a obrigação de adotar os meios necessários às “ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde” (art. 198, da Constituição Federal), prestando “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” (art. 6º, da Lei nº 8.080/90), sendo a “integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais... exigidos para cada caso...” (art. 7º, inciso “II”, da Lei nº 8.080/90), **DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA** para determinar aos réus que, dentro de suas esferas de competências administrativas, forneçam à autora o medicamento **RITUXIMABE**, na dose e no tempo prescritos pela médica assistente, consoante laudo médico emitido pela Dra. Érika Monteiro França (CRM/RJ: 52124995-9), integrante dos quadros do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (Evento 1- Anexo 2 Fls. 10/16), com a realização dos exames necessários, prescritos pelo médico na ocasião ou outro que for necessário nas circunstâncias atuais, à vista do real estado de saúde da requerente, sem olvidar da necessidade de eficiência do tratamento e seus custos, sob responsabilidade penal, civil e administrativa dos responsáveis, na forma da lei.*

Aquele ente que fornecer o medicamento à autora deverá responsabilizar-se por proceder à comunicação do respectivo fornecimento aos demais, com vistas a evitar a liberação simultânea de medicamento em favor da autora e em detrimento de outros pacientes.

Intimem-se e cite-se, COM URGÊNCIA, os réus por meio de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça.

Sem prejuízo, proceda à parte autora com a regularização de sua representação processual, com a juntada aos autos do instrumento de procuração.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2024."

Argumenta a União existirem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não tendo sido comprovada a imprescindibilidade do medicamento.

Pontua que o Rituximabe não se encontra padronizado para a patologia da Autora, mas tão somente para artrite reumatoide, sendo disponibilizado pelo CEAF.

No mais, alega risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e que o cumprimento seja direcionado ao Estado do Rio de Janeiro.

Liminar parcialmente deferida - evento 3, DESPADEC1.

Contrarrazões da parte autora - evento 11, CONTRAZ1.

Manifestação do Município do Rio de Janeiro - evento 13, OFIC2.

VOTO

Tendo em vista que não houve qualquer alteração no quadro fático, deve ser mantido o já fundamentado na decisão do evento 3, DESPADEC1, que passa a fazer parte integrante do presente voto

A Autora, atualmente em tratamento no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, foi diagnosticada com pênfigo vulgar e, de acordo com laudo médico, necessita iniciar terapia alternativa com o medicamento Rituximabe. Afirma já ter utilizado os medicamentos prednisona, azatioprina e sulfazidina em doses altas, mas com baixa resposta clínica (evento 1, ANEXO2, fls. 11/19)(evento 7, PET1).

4- SOBRE A ENFERMIDADE

4.1. Enfermidade CID: L10.0

4.2. Histórico da doença: Paciente apresentando quadro clínico de lesões exulcerativas bem delimitadas em pele e mucosas de surgimento há 2 meses, com diagnóstico histopatológico e clínico de pênfigo vulgar. Fez uso de doses altas de prednisona e azatioprina com baixa resposta clínica, necessitando de início de terapia alternativa com Rituximabe.

4.3. Tratamentos já realizados/Resultados:

Prednisona 820 mg/dia, Azatioprina 100 mg/dia e sulfazidina de prata nos lesões, sem resposta totalmente efetiva.

5 - SOBRE O MEDICAMENTO SOLICITADO E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1. DCB (Denominação Comum Brasileira): Rituximabe

(na ausência nesta, a DCI - Denominação Comum Internacional.)

5.2. Forma farmacêutica: Rituximabe

5.3. Dose: 10 mg/ml - 1000 mg

5.4. Forma de administração: IV

5.5. Duração do tratamento: (18 meses) - 2 infusões no 1º mês e repetir mais 2 infusões após 6, 12 e 18 meses da 1ª infusão

5.6. O medicamento prescrito está registrado na Anvisa? ☒ Sim ☐ Não

5.7. Tem registro em país estrangeiro? ☒ Sim ☐ Não. Se sim, qual(is) país(es)? _____

5.8. Trata-se de prescrição com indicação não incluída na bula (uso off label)? ☒ Sim ☐ Não.

5.9. O medicamento prescrito é padronizado no SUS? ☐ Sim ☒ Não.

7- SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO

7.1. É urgente: ☒ Sim ☐ Não. Se sim, por que? Por a paciente é refratária a múltiplas terapias prévias (azatioprina, prednisona doses altas)

7.2. É imprescindível: ☒ Sim ☐ Não. Se sim, por que? Por a paciente é refratária a múltiplas terapias prévias (azatioprina, prednisona doses altas)

7.3. A ausência de fornecimento do medicamento, insumo ou procedimento prescrito poderá ocasionar quais das seguintes consequências:

☒ Risco de morte

☐ perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas

☒ Grave comprometimento do bem estar

☒ Outras. Especificar: complicações como sepse cutânea

8 - SOBRE OS BENEFÍCIOS E RISCOS ESPERADOS COM O USO DO MEDICAMENTO

8.1. Descrever os benefícios esperados e os critérios ou parâmetros que serão utilizados para o acompanhamento da resposta terapêutica: controle de lesões cutâneas e cavidade oral e evitar o aparecimento de novas lesões.

8.2 Descrever os efeitos adversos esperados com o uso do medicamento e os meios a serem empregados para redução dos mesmos: infusões e reações relacionadas a infusão. São documentadas infusões ativas prévias e durante a infusão para outros medicamentos por infusões e acomp. clínico e laboratorial

9 - SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO

9.1. Descrever: manutenção das lesões da pele e cavidade oral, impossibilidade de labor e satisfação devido o efeitos adversos anteriores e possibilidade de óbito por complicações.

Parecer do NAT esclarece que o medicamento possui registro na ANVISA e está indicado em bula para o tratamento do quadro clínico da Autora, caracterizado por uma doença rara e grave. Salienta que o medicamento é disponibilizado pelo CEFAP, mas para doença diversa a da Autora (evento 22, PARECER1).

1. Refere-se à Autora com **pênfigo vulgar**, apresentando solicitação médica para tratamento com **Rituximabe**.

2. Posto isto, informa-se que o medicamento **Rituximabe possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e **está indicado em bula**² para o tratamento do quadro clínico apresentado pela Autora – **pênfigo vulgar**, conforme relatado em documento médico.

3. No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado, insta mencionar que **Rituximabe**, pertence ao **grupo 1A** de financiamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica³ (CEFAP), **é disponibilizado** pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), apenas aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pelo Ministério da Saúde, bem como ao disposto no Título IV da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 (estabelece as normas de financiamento e de execução do CEFAP). **Os medicamentos do CEFAP somente serão autorizados e disponibilizados para as doenças** (Classificação Internacional de Doenças, CID-10) **contempladas no PCDT, e na legislação.**

4. Destaca-se que a doença da Demandante a saber, **L10 – Pênfigo, não está dentre as contempladas para a retirada do medicamento através do CEFAP, impossibilitando a obtenção do Rituximabe pela via administrativa.**

5. O medicamento **Rituximabe** até o momento **não foi avaliado** pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)⁴ para o tratamento do **pênfigo vulgar**.

6. Acrescenta-se que o **pênfigo vulgar** é enfermidade grave **relativamente rara, com incidência de 0,1 a 0,5 casos por cem mil habitantes cada ano**⁵. Assim, cumpre salientar que o Ministério da Saúde instituiu a **Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras**, aprovando as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS e instituiu incentivos financeiros de custeio. Ficou estabelecido que a **Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras**⁶ tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos.

8. Sobre o tratamento medicamentoso que pode ser fornecido à parte autora pelo SUS, em alternativa ao solicitado, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) disponibiliza, aos pacientes que perfazem os critérios de inclusão para tratamento de pênfigo vulgar, o medicamento Azatioprina 50mg comprimido.

9. Entretanto, cabe resgatar o exposto no laudo emitido pela médica assistente (Evento 1, ANEXO2, Páginas 10-16) de que a Autora já fez uso de altas doses de Azatioprina e Prednisona, mantendo-se refratária. Assim, a terapêutica disponibilizada no SUS não atende à necessidade da Requerente.

10. No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)⁹.

11. De acordo com publicação da CMED¹⁰, o Preço Fábrica (PF) deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

12. Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta a Tabela de Preços CMED, para o ICMS 20%, tem-se:

- **Rituximabe 10mg/mL**, 1 frasco vidro com 50mL, apresenta menor preço de fábrica consultado correspondente a R\$ 7.134,63 e menor preço máximo de venda ao governo consultado correspondente a R\$ 5.598,54.

Pois bem.

Da análise dos documentos médicos colacionados aos autos, verifica-se que as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS não se mostraram eficazes no tratamento da Autora e que o uso do rituximabe é imprescindível e urgente, considerando o risco de morte, sepse cutânea e grave comprometimento do bem estar.

No tocante à alegação de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a urgência e necessidade do insumo pleiteado encontram-se devidamente demonstradas nos autos, não cabendo afastá-los em razão de alegações genéricas e não comprovadas por parte da União.

Entendo, ainda, que deva ser aplicado o princípio da proporcionalidade para afastar a irreversibilidade do provimento adotado, a fim de que seja protegido o interesse maior lastreado no direito constitucional à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CRFB/88, em detrimento do interesse financeiro do Estado.

No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, a 8.ª Turma Recursal já assim firmou seu entendimento:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102."

Observa-se que a decisão impugnada determinou que os Réus, dentro de suas competências administrativas fornecessem o medicamento. Entretanto, não direcionou o cumprimento a nenhum deles.

Considerando que o medicamento rituximabe é disponibilizado pelo Estado do Rio de Janeiro, ainda que para doença diversa, entendo que o cumprimento da tutela, inicialmente, deva ser iniciado pelo referido ente.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso determinando que o cumprimento da tutela deferida na origem seja, inicialmente, direcionado ao Estado do Rio de Janeiro, nos termos do tema 793 do STF, ante a possibilidade de estoque.** Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.